Boletín Epidemiológico N° 27 de 2025

Dirección de Vigilancia de la Salud

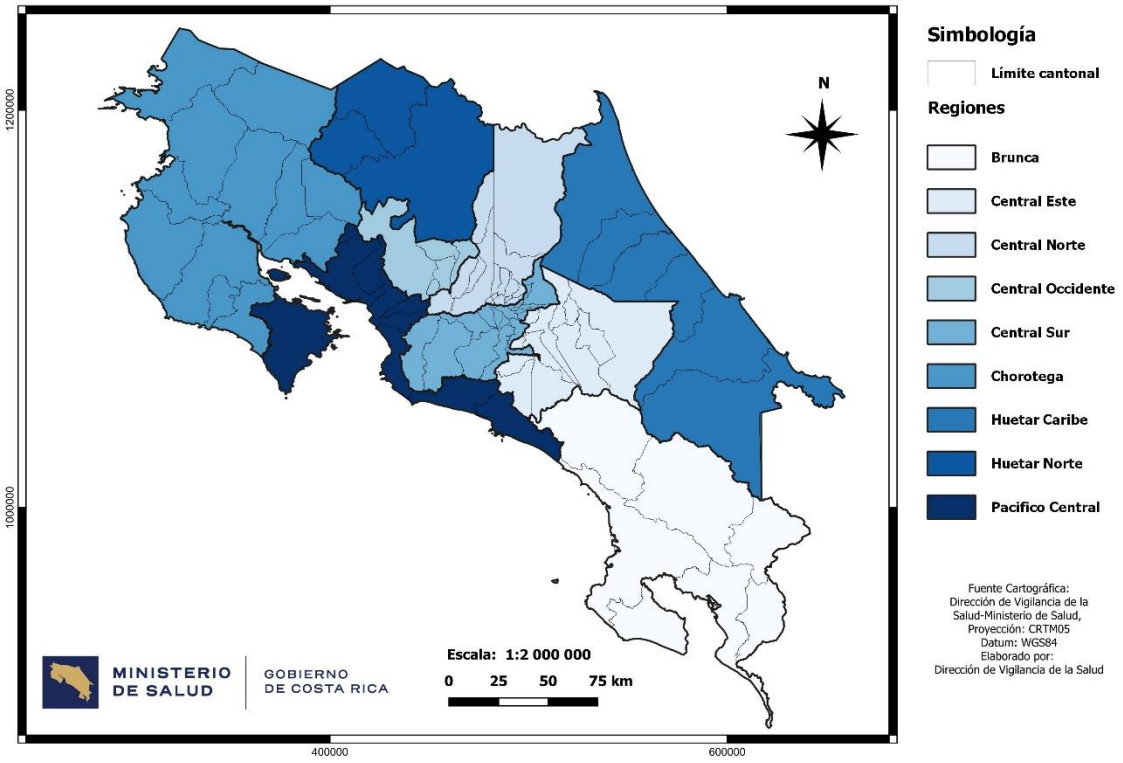
Ministerio de Salud

24 de julio de 2025

Tabla de contenido

Arbovirosis 3
Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 28 .. 8
Malaria 10
Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19 18
Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 34
Meningitis 36
Infecciones de transmisión sexual 40
Miasis por gusano barrenador en humanos 53

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024



Arbovirosis

Adriana Alfaro Nájera
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de Salud

Adrián Montero Bonilla
Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Dengue

A la semana epidemiológica 28 del año 2025 se notifican **2436 casos** de dengue, de estos 24 acumulados notificados con signos de alarma.

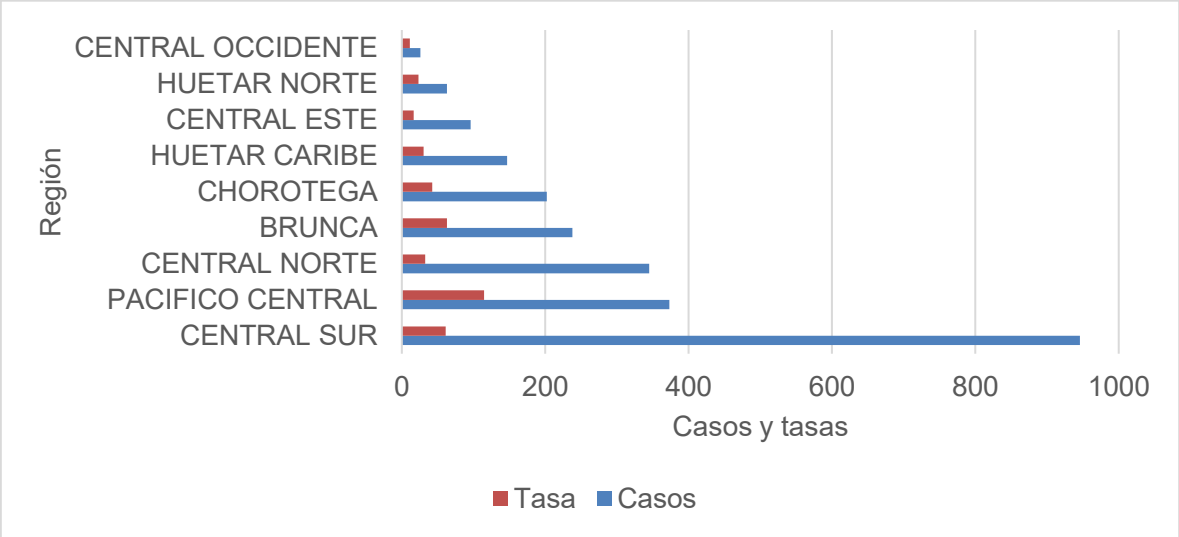
En la región Central Sur se concentra la mayor notificación acumulada con 946 casos y la tasa más alta en la Pacífico Central 114,9/100.000 habitantes.

Tabla 1.
Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región a la semana epidemiológica 28, 2025 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
CENTRAL SUR	946	60,9
PACIFICO CENTRAL	373	114,9
CENTRAL NORTE	345	32,6
BRUNCA	238	62,8
CHOROTEGA	202	42,3
HUETAR CARIBE	147	30,4
CENTRAL ESTE	96	16,6
HUETAR NORTE	63	23,1
CENTRAL OCCIDENTE	26	11,3
Total	2436	45,5

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 1.
Costa Rica: casos de dengue y tasa por región a la semana epidemiológica 28, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

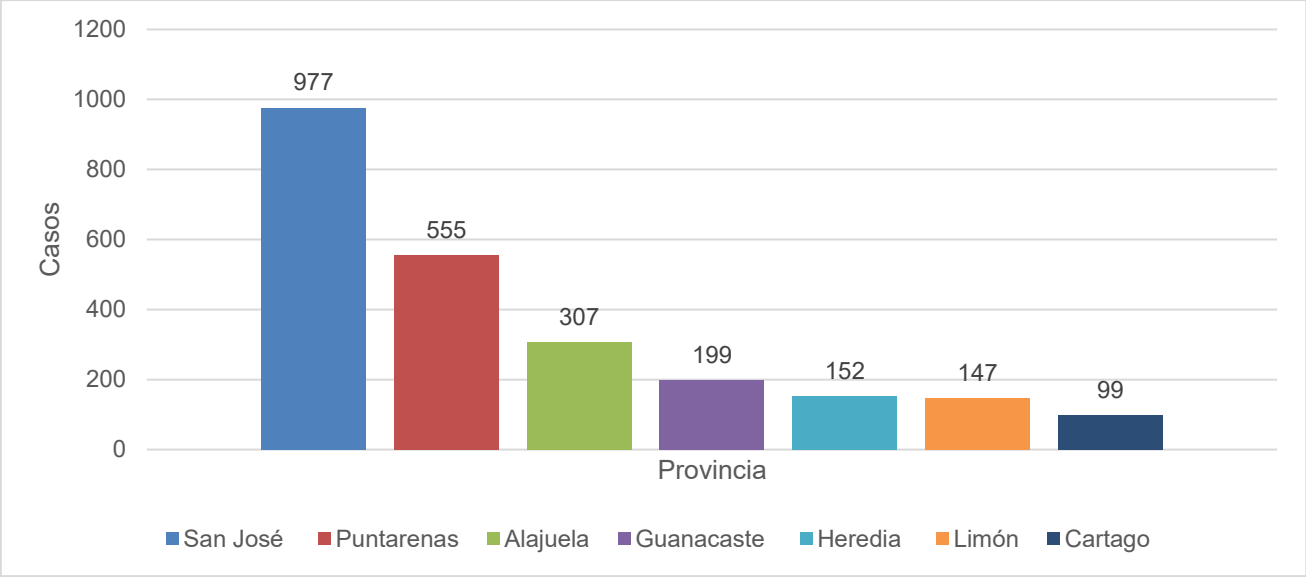
En la tabla 2 se pueden observar los casos notificados por provincia y sexo para el año 2025.

Tabla 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia y sexo, 2025

Provincia	Total casos	Tasa	Femenino	Tasa	Masculino	Tasa
San José	977	56,9	493	57,1	484	56,7
Puntarenas	555	105,2	250	96,4	305	113,8
Alajuela	307	28,1	165	30,5	142	25,7
Guanacaste	199	47,4	88	42,4	111	52,1
Heredia	152	27,2	74	26,6	78	27,8
Limón	147	30,4	59	25,1	88	35,4
Cartago	99	17,8	43	15,5	56	20,1
Total	**2436**	**45,5**	**1172**	**44,0**	**1264**	**46,9**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia a la semana epidemiológica 28, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Los cantones con mayor número de casos acumulados a la semana epidemiológica 28 son: San José 576 casos, Alajuela 147 casos, Esparza 129 casos, Puntarenas 126 casos, y Sarapiquí 99 casos.

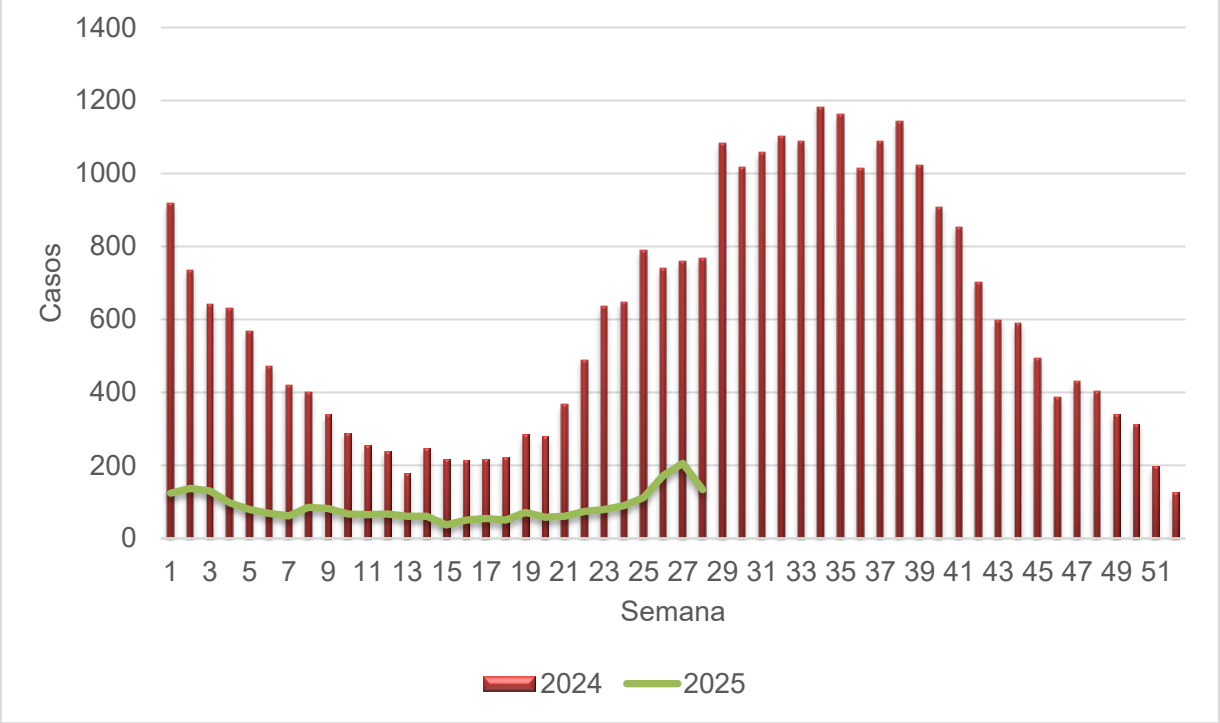
Tabla 3.
Costa Rica: cantones prioritarios en casos de dengue a la semana epidemiológica 28, 2025.

Cantón	Casos	Tasa
101: San José	576	160,9
201: Alajuela	147	44,2
602: Esparza	129	316,5
601: Puntarenas	126	84,4
410: Sarapiquí	99	104,7
110: Alajuelita	90	89,3
610: Corredores	82	149,1
103: Desamparados	67	26,3
605: Osa	59	186,2
702: Pococí	55	34,3

109: Santa Ana	51	79,9
210: San Carlos	46	21,4
607: Golfito	45	94,0
609: Parrita	43	194,5
502: Nicoya	42	71,1
119: Pérez Zeledón	34	23,7
113: Tibás	29	33,1
305: Turrialba	29	39,6
506: Cañas	28	81,4
118: Curridabat	27	32,9

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Figura 3.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 28, 2024-2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

A la semana epidemiológica 28 del 2024 se reportó un total de 12964 casos de dengue, para este 2025 se reportan 2436 para un descenso del 81% con respecto a la misma semana epidemiológica.

Tabla 4.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 28, 2024-2025.

Semana	2024	2025
1	917	124
2	735	137
3	641	130
4	631	98
5	568	79
6	472	69
7	421	62
8	401	85
9	340	82
10	289	67
11	256	65
12	238	67
13	178	61
14	247	61
15	216	37
16	214	50
17	216	55
18	223	50
19	285	71
20	280	58
21	368	61
22	489	74
23	636	79
24	648	90
25	790	112
26	739	172
27	758	206
28	768	134
Total	**12964**	**2436**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 28

Rodrigo Marín Rodríguez
Programa de Control de Vectores
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud.

Rose Mary Hidalgo Ríos
Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM)

En la siguiente tabla se desglosan las acciones de control vectorial que se han realizado en la Semana Epidemiológica 28 del 2025, por el personal de Control de Vectores del país.

Cuadro 1.
Costa Rica: Acciones de control vectorial en la Semana Epidemiológica 28 del 2025

	Total
Viviendas visitadas	**10.480**
Viviendas positivas	**633**
Depósitos tratados	**32.884**
Depósitos eliminados	**13.932**
Depósitos positivos	**896**
Viviendas fumigadas	**9.432**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Cuadro 2
Así mismo se detalla lo que llevamos de la 1 a la 28 de 2025.

	Total
Viviendas visitadas	**343.228**
Viviendas positivas	**15.286**
Depósitos tratados	**1.280.643**
Depósitos eliminados	**903.429**
Depósitos positivos	**26.798**
Viviendas fumigadas	**325.240**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Malaria

Isaac Vargas Roldán
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Sarah Arce Bonilla
Dirección de Vigilancia de la Salud

I. Antecedentes

Costa Rica ha logrado mantener bajos niveles de transmisión de malaria gracias a los esfuerzos continuos y control. Los casos han disminuido notablemente en comparación con el pasado.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) lideran los esfuerzos de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de la malaria, junto con el apoyo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). Se utilizan herramientas para el diagnóstico rápido y monitoreo constante de los casos.

Costa Rica forma parte de la **Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana (IREM)** es un esfuerzo conjunto de varios países y organizaciones internacionales con el objetivo de eliminar la malaria en esta región. Esta iniciativa busca coordinar acciones, compartir recursos y conocimientos, y establecer estrategias comunes para combatir y erradicar esta enfermedad.

El objetivo principal para este año es mantener la reducción sostenida de casos de malaria y avanzar hacia la meta de eliminación. Costa Rica se perfila como el próximo país de la región en obtener la certificación de cero casos autóctonos de malaria.

Como parte de las acciones se está priorizando el **fortalecimiento de la red de colaboradores voluntarios** en comunidades con barreras de acceso a los servicios de salud y esfuerzos para acerca el diagnóstico y tratamiento a personas en condición de movilidad humana que llevan su paso por el país.

II. Vigilancia epidemiológica

El histórico de transmisión local de malaria presenta los casos registrados en los años 2023, 2024 y 2025, organizados por semana epidemiológica. Se observa una tendencia general a la disminución de casos en el periodo analizado.

Durante el periodo comprendido entre las semanas epidemiológicas 1 a 28, se observa una disminución progresiva en el número de casos de transmisión local de malaria a lo largo de los últimos tres años. En el año 2023, se registraron 363 casos, mientras que en 2024 la cifra se redujo a 157 casos, lo que representa una disminución del 57%. En lo que va del año 2025, se han reportado 7 casos autóctonos, lo que equivale a una reducción del 98% en comparación con el mismo periodo de 2023.

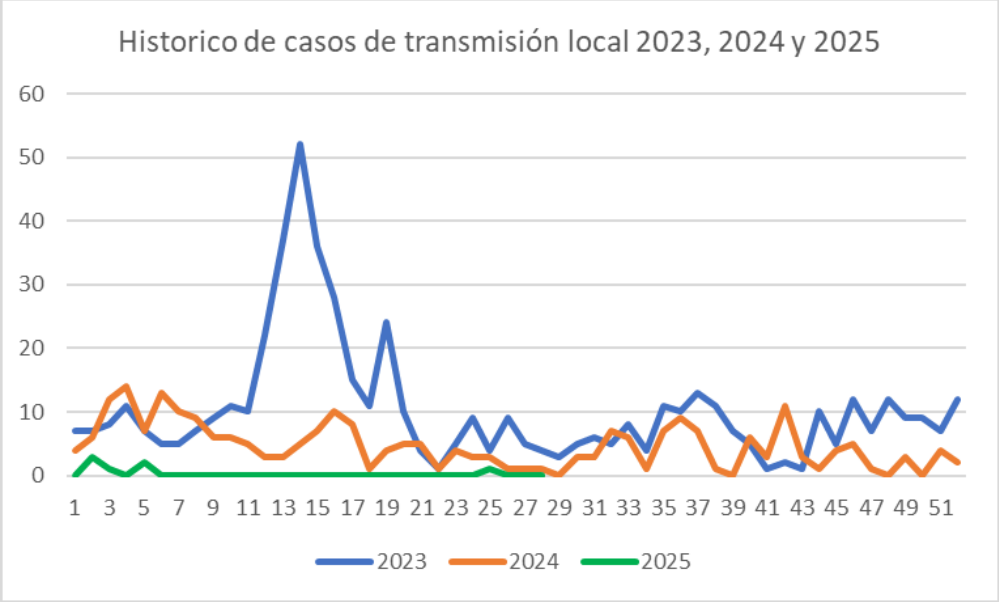
Adicionalmente, en lo que va del año 2025, se ha registrado 1 caso introducido en Santa Rosa de Pocosol y se han detectado 18 casos importados de malaria, de los cuales el 83% corresponden a *Plasmodium vivax* (n=15) y el 17 % a *P. falciparum* (n=3), con transmisión ocurrida fuera del país, estos casos fueron identificados en las localidades de San Pablo (Nandayure), San Ramón (San Ramón), Corredores, Pavas (San José), Cutris (San Carlos) y Los Chiles.
Las personas afectadas se desempeñan principalmente como operarios de construcción, peones agrícolas y coligalleros, así como personas en condición de movilidad humana, provenientes de Nicaragua, de la ruta migratoria desde América del Sur, o en retorno desde México y Gabón (África).
Adicionalmente, se tienen 5 casos del foco de Crucitas en estudio, lo que suma un total de 31 casos reportados en lo que va del año.

Tabla 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE26.

Histórico Transmisión local			
Semana Epidemiológica	2023	2024	2025
1	7	4	0
2	7	6	3
3	8	12	1
4	11	14	0
5	7	7	2
6	5	13	0
7	5	10	0
8	7	9	0
9	9	6	0
10	11	6	0
11	10	5	0
12	22	3	0
13	37	3	0
14	52	5	0
15	36	5	0
16	28	7	0
17	15	8	0
18	11	1	0
19	24	4	0
20	10	5	0
21	4	5	0
22	1	1	0
23	5	4	0
24	9	3	0
25	4	3	1
26	9	1	0
27	5	1	0
28	4	1	0
Total	**363**	**157**	**7**

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Gráfico 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE 28.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Producción de pruebas de diagnóstico

Se ha llevado a cabo un exhaustivo monitoreo a nivel nacional de la malaria, por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud realizando pruebas de diagnóstico mediante búsquedas pasivas y activas de casos.

A semana epidemiológica 28, se registraron 71.152 pruebas de diagnóstico, las cuales responden a las búsquedas realizadas por las instituciones, desglosadas de la siguiente manera, (refiérase a la figura 1):

- **Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por el Ministerio de Salud**: 33.580 referirse a la tabla 2.
  - **Colaboradores Voluntarios**: 768
  - **Inspectores de Salud**: 32.812

- **Pruebas de diagnóstico realizadas por CCSS**: 37.959, referirse al gráfico 3.
  - **Gotas gruesas**: 6.815
  - **Pruebas de diagnóstico rápido**: 30.787
  - **PCR**: 357

Estas cifras reflejan un esfuerzo coordinado y continuo para identificar y controlar la propagación de la malaria en el país. La combinación del método tradicional como lo es la gota gruesa y las pruebas rápidas permite una detección más amplia y oportuna de casos, contribuyendo significativamente a la vigilancia epidemiológica y al manejo efectivo de esta enfermedad.

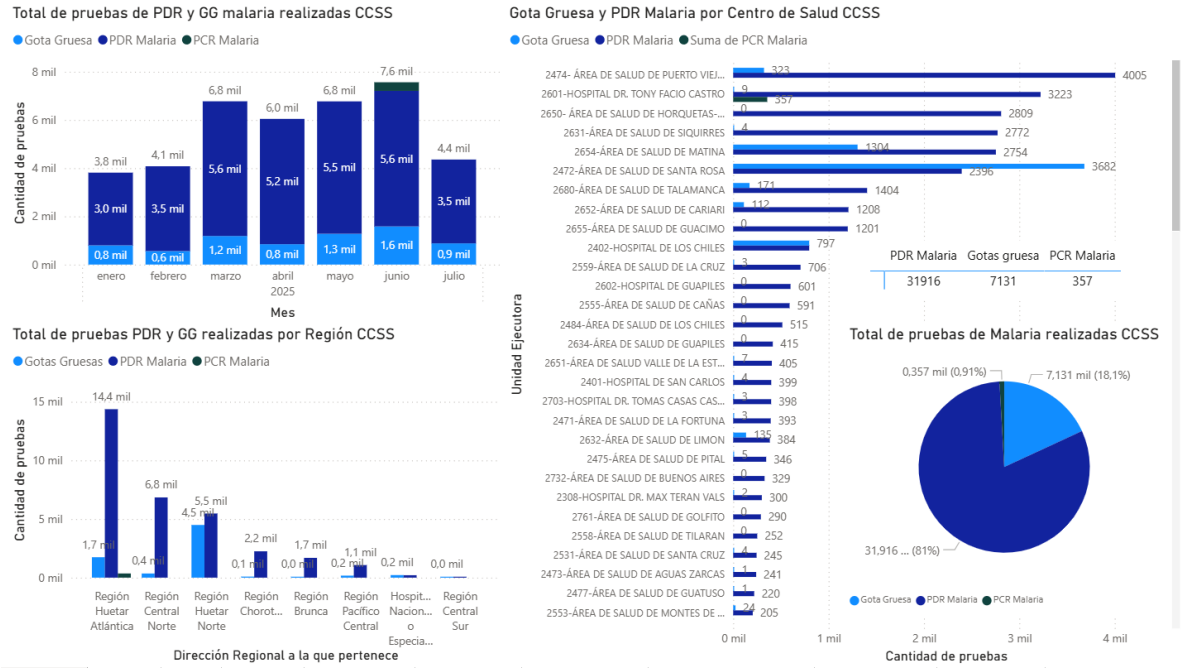
Nota: El registro puede incluir datos duplicados, ya que se toman en cuenta las Gotas Gruesas (GG) para cuantificar la parasitemia antes de iniciar el tratamiento, ante una Prueba de Diagnóstico Rápido (PDR) positiva.

Tabla 2.
Costa Rica: Vigilancia generada por inspectores de salud y voluntarios

Región	Pruebas realizadas por Inspectores de Salud	Pruebas realizadas por voluntarios
Brunca	11849	53
Central Norte	168	28
Chorotega	4628	137
Huetar Caribe	6844	209
Huetar Norte	8024	309
Pacífico Central	1298	32
Total	32812	768

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Gráfico 3.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS



Fuente: CCSS.

Tabla 2.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS por región.

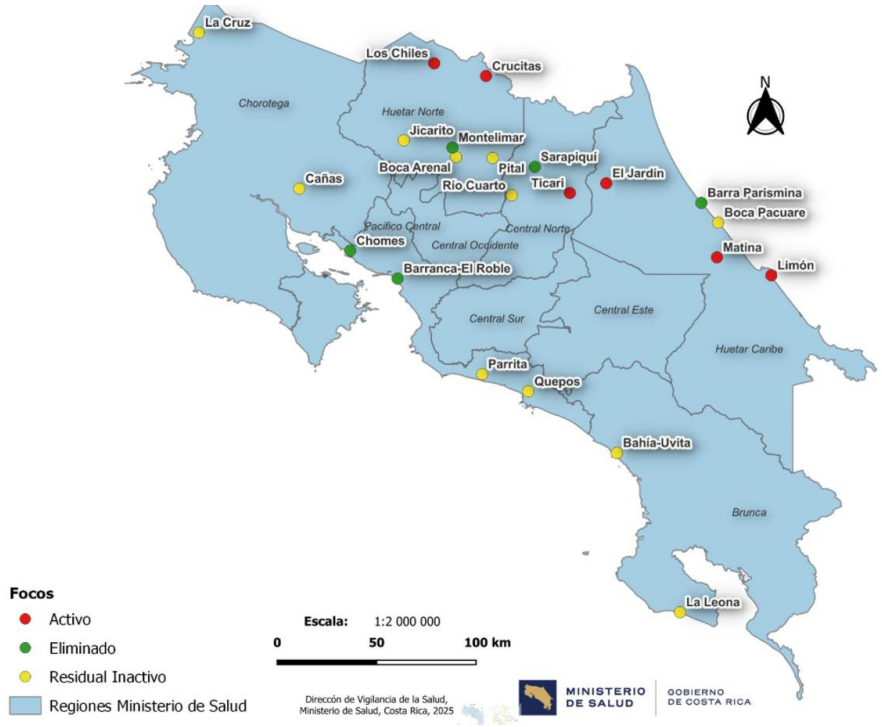
Dirección Regional a la que pertenece	Gotas Gruesas	PDR Malaria	PCR Malaria
Región Huetar Atlántica	1742	14369	357
Región Central Norte	354	6842	
Región Huetar Norte	4493	5471	
Región Chorotega	89	2246	
Región Brunca	33	1687	
Región Pacífico Central	171	1072	
Hospitales Nacionales o Especializados	217	206	
Región Central Sur	32	23	
Total	**7131**	**31916**	**357**

Fuente: CCSS.

III. Inventario de focos.

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 6 focos activos, 10 focos residuales inactivos y 5 focos eliminados.

Figura 1.
Costa Rica: Inventario de focos de Malaria a mayo 2025.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

IV. Clasificación del estado histórico y actual de los focos maláricos.

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

Tabla 3.
Costa Rica: Listado de Focos de malaria a Enero 2025, por provincia, cantón y estado actual del foco.

Provincia	Cantón	Nombre del Foco	Estado
Alajuela	San Carlos	Pital	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Boca Arenal	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Monterrey	Eliminado
Alajuela	San Carlos	Crucitas - Llano Verde	Activo
Alajuela	Los Chiles	Los Chiles	Activo
Alajuela	San Carlos	Jicarito	Residual inactivo
Alajuela	Río Cuarto	Rìo Cuarto	Residual inactivo
Guanacaste	La Cruz	La Cruz	Residual inactivo
Guanacaste	Cañas	Cañas	Residual inactivo
Heredia	Sarapiquí	Sarapiquí	Eliminado
Heredia	Sarapiquí	Ticari	Activo
Limón	Matina	Matina	Activo
Limón	Limón	Limón	Activo
Limón	Siquirres	Barra de Parismina	Eliminado
Limón	Pococí	El Jardín	Activo
Limón	Siquirres	Barra Pacuare	Residual inactivo
Puntarenas	Roble	El Roble	Eliminado
Puntarenas	Puntarenas	Chomes	Eliminado
Puntarenas	Quepos	Quepos	Residual inactivo
Puntarenas	Parrita	Parrita	Residual inactivo
Puntarenas	Golfito	La Leona	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	Bahia Uvita	Residual inactivo

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19

Roberto Arroba Tijerino
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Mayra Quesada Sanabria
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

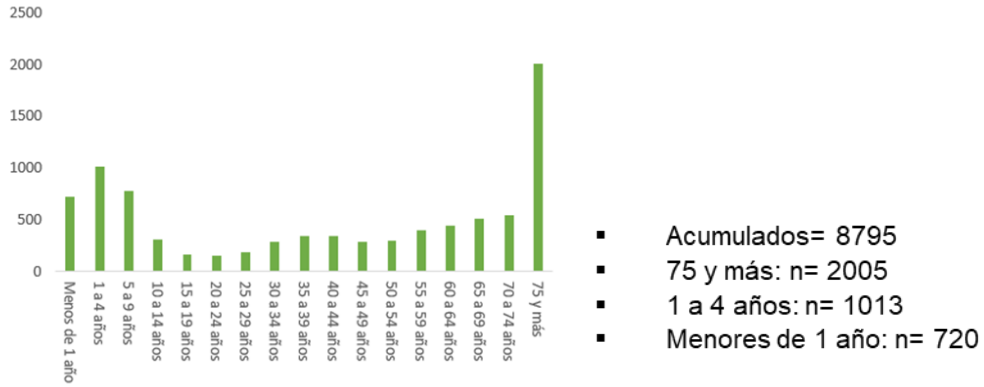
Rafael Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos para la semana epidemiológica 27 de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) y los datos de la semana epidemiológica 27 de las Infecciones Respiratorias Agudas Superiores (IRAS) y la Enfermedad Tipo Influenza (ETI), que según establece el Decreto de Vigilancia de la Salud No. 40556-S del 07 julio del 2017, son eventos de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de las IRAG, por medio de la boleta VE-01, se cuenta con los siguientes datos:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 27 son un total de 8795.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en los niños entre 1 y 4 años y en los mayores de 75 años.

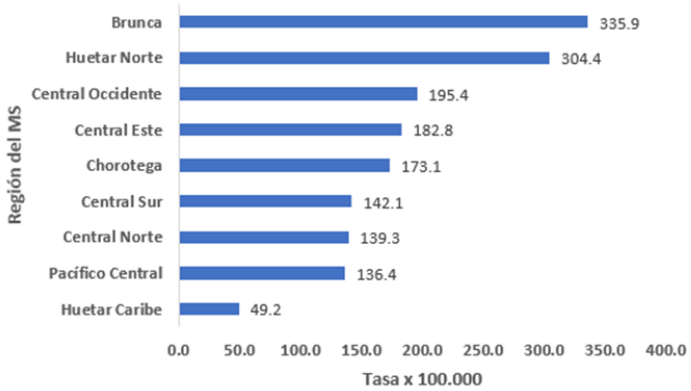
Gráfico 1.
Distribución de casos de IRAG por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 27, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según el gráfico 1, se puede apreciar como en los extremos de la vida (niños entre 1 y 4 años y mayores de 75 años es donde más casos se han presentado).
En el gráfico 2, se observa la tasa de incidencia de IRAG según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 27, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Brunca y la Huetar Norte; las regiones con menor incidencia corresponden a la Chorotega, Central Este, Central Occidente, Central Sur, Central Norte, Pacífico Central y Huetar Caribe.

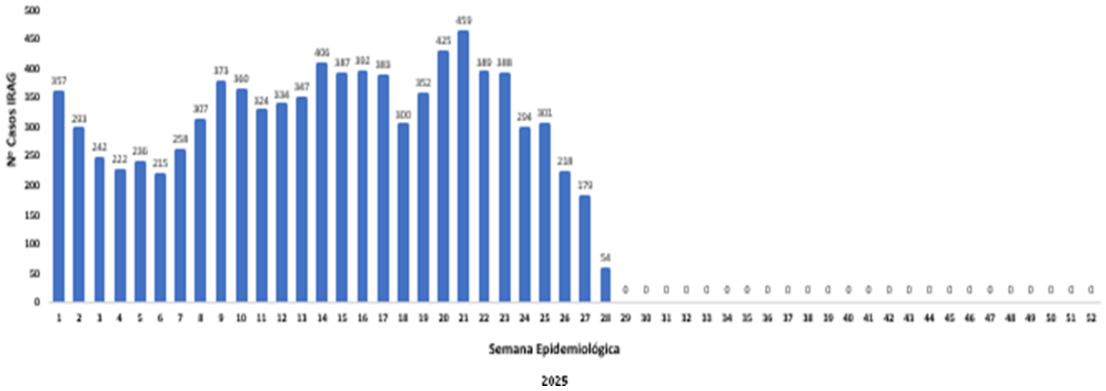
Gráfico 2.
Tasa de IRAG según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 27 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-01 de IRAG, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 3; se puede observar el comportamiento de los casos a la semana epidemiológica 27 del año 2025.

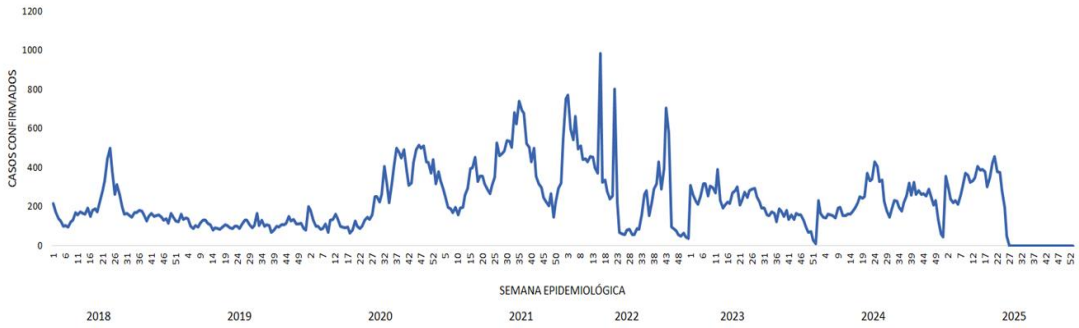
Gráfico 3.
Distribución de casos reportados por boleta VE-01 de IRAG a la semana epidemiológica 27, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAG, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 4.

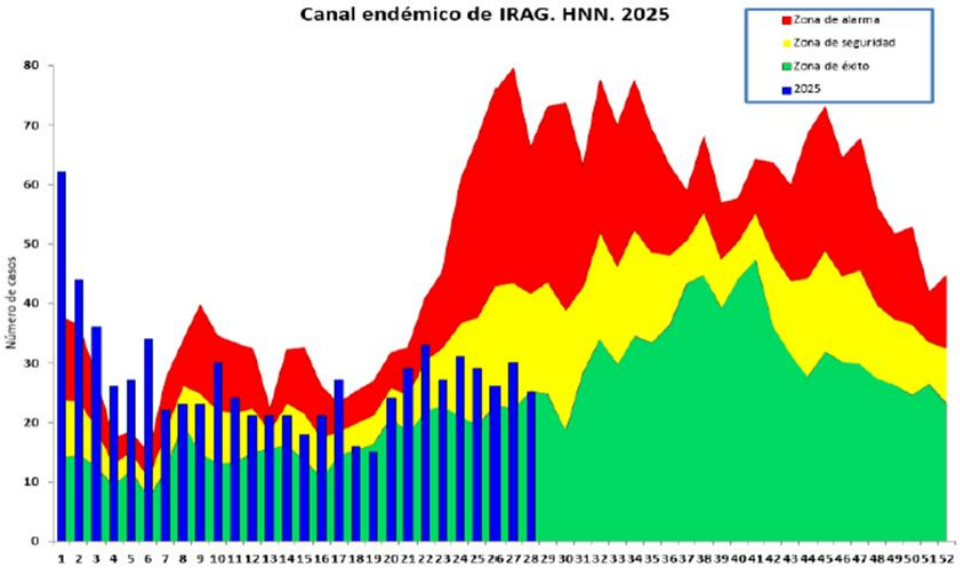
Gráfico 4.
Distribución histórica de casos de IRAG por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

El HNN, para la SE-27 tiene un canal endémico de IRAG que actualmente se encuentra por en zona de éxito, debido a la cantidad de casos que están presentando en este momento, tal como se puede apreciar en el gráfico 5.

Gráfico 5.
Costa Rica: Canal endémico IRAG, HNN, 2025

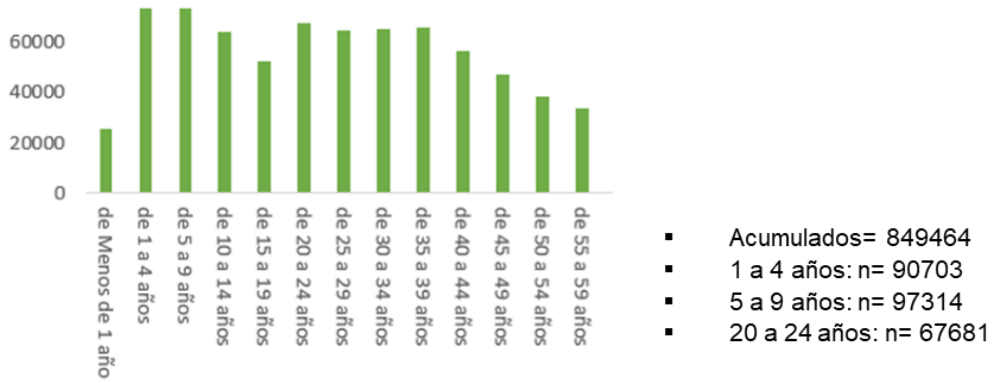


Fuente: EDUS-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de IRAS, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 6:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 27 son 849464.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en menores entre 1 y 4 años y menores entre 5 y 9 años.

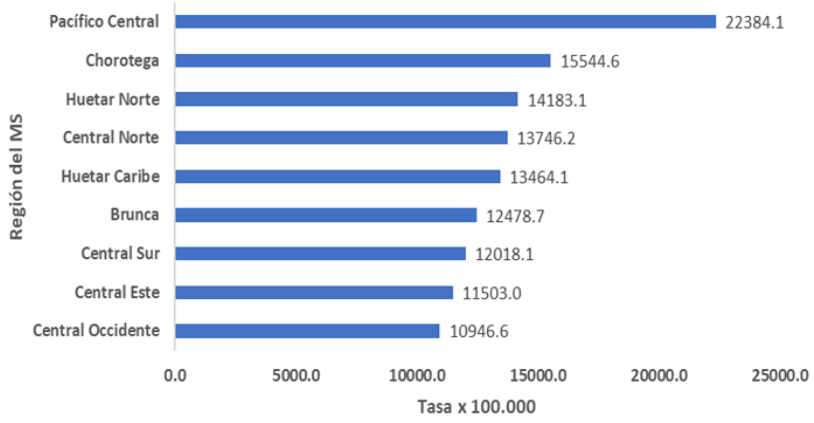
Gráfico 6.
Distribución de casos de IRAS por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 27, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 7, se observa la tasa de incidencia de IRAS según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 27, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Pacífico Central, Chorotega y Huetar Norte. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Central Norte, Huetar Caribe, Brunca, Central Occidente, Central Sur y Central Este.

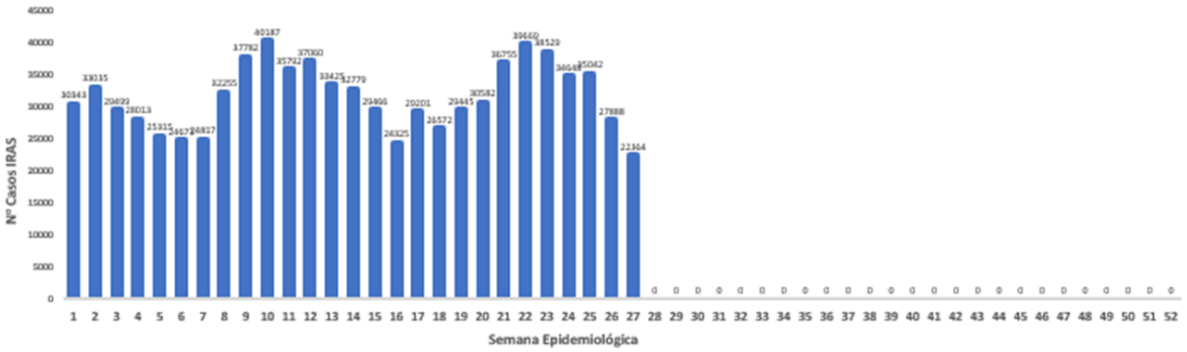
Gráfico 7.
Tasa de IRAS según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 27 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de IRAS, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 8; se puede observar cómo los casos se han comportado a lo largo de estas 27 semanas epidemiológicas del año 2025.

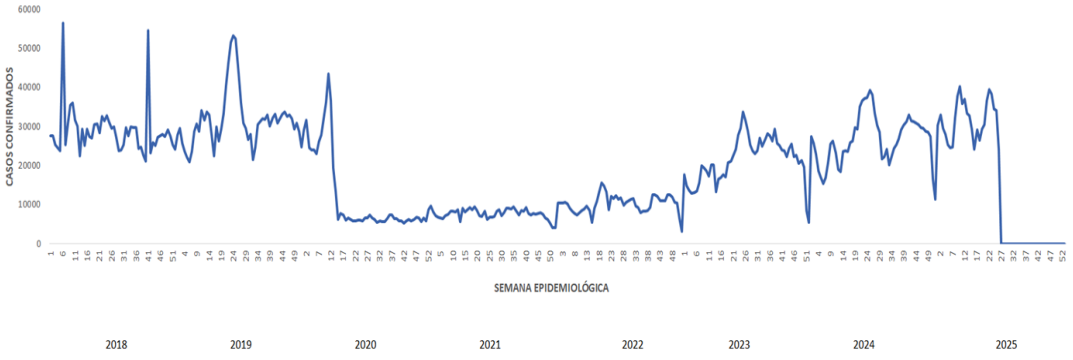
Gráfico 8.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de IRAS a la semana epidemiológica 27, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAS, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 9.

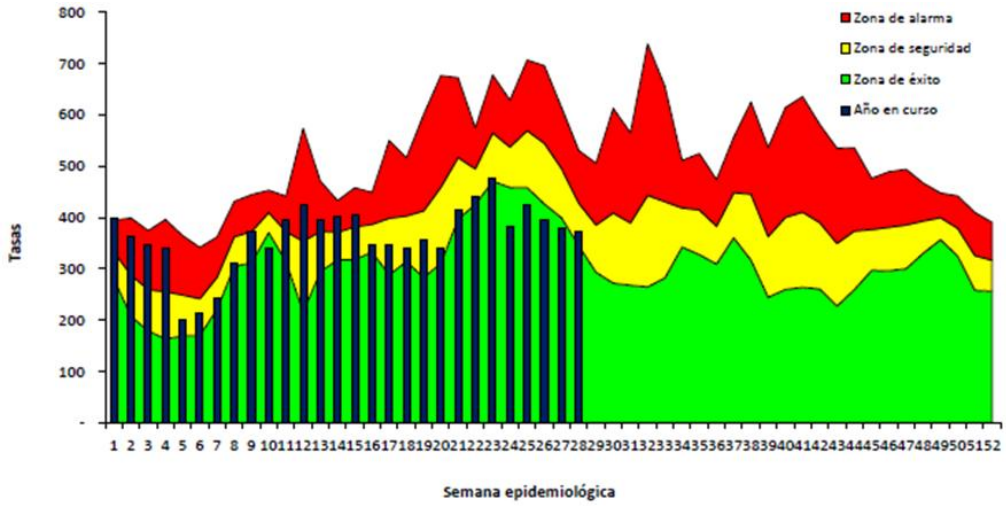
Gráfico 9.
Distribución histórica de casos de IRAS por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 10 se presenta el canal endémico de las IRAS en el Hospital Nacional de Niños, que muestra que a la semana 27 se encuentran en la zona de seguridad actualmente.

Gráfico 10.
Costa Rica: Canal endémico IRAS. HNN. 2025.

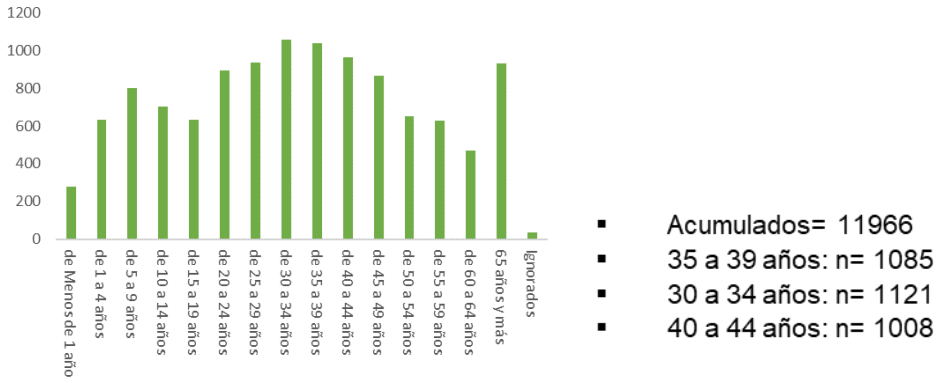


Fuente: Sistemas de Cubos Urgencias-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de ETI, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 11:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 27 son n= 11996.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en personas entre 30 y 34 años y las personas entre 35 y 39 años.

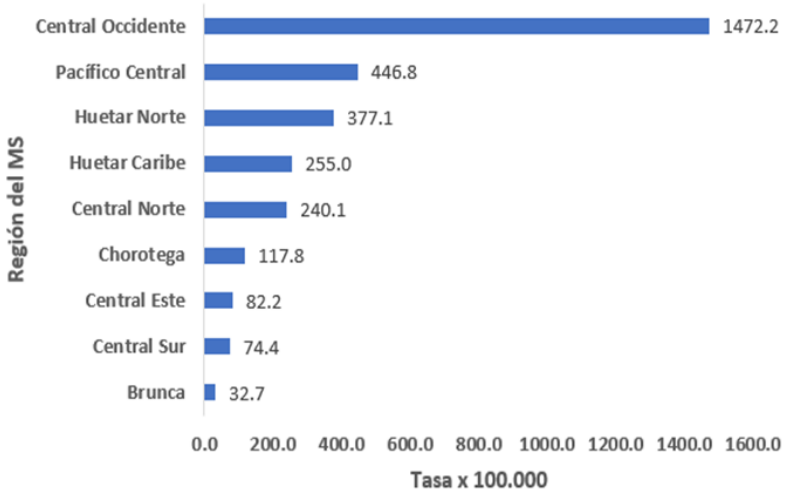
Gráfico 11.
Distribución de casos de ETI por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 27, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 12, se observa la tasa de incidencia por ETI, según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 27, presentando mayor cantidad de casos en la región la Central Occidente. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Brunca, Chorotega, Central Este, Central Sur, Huetar Norte, Pacífico Central, Central Norte y Huetar Caribe.

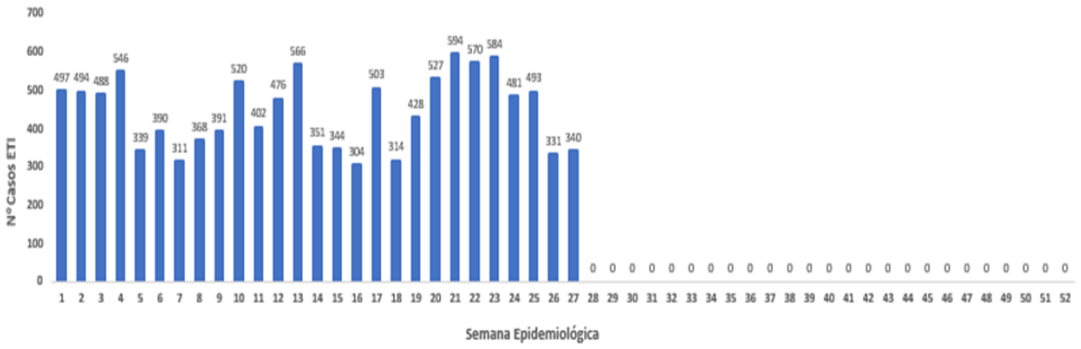
Gráfico 12.
Tasa de ETI por región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 27 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de ETI, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 13; se puede observar cómo se han distribuido los casos en el año 2025.

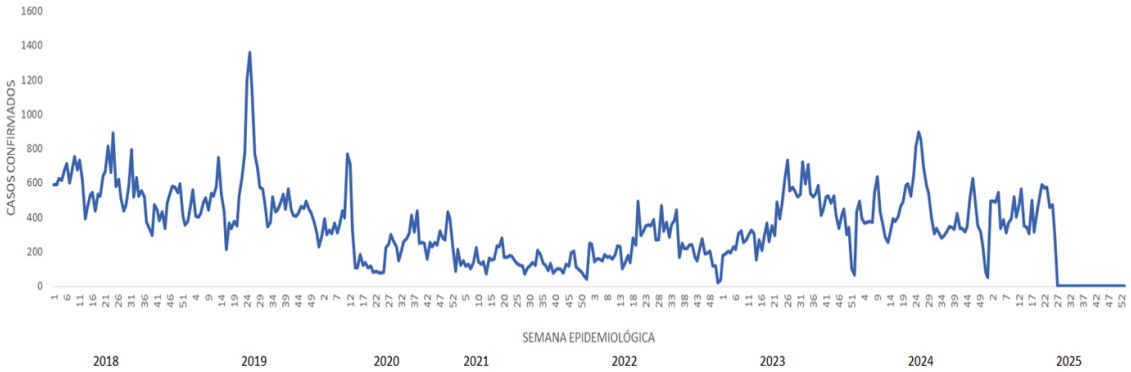
Gráfico 13.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de ETI a la semana epidemiológica 27, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de ETI, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 14.

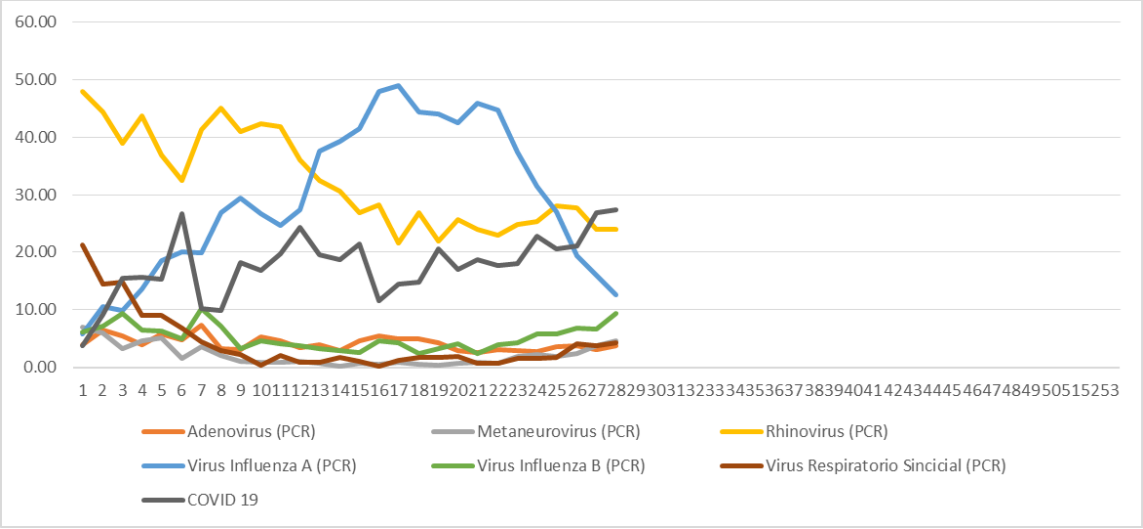
Gráfico 14.
Distribución histórica de casos de ETI por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según se observa en el gráfico 15, se puede ver el comportamiento de los principales virus respiratorios circulantes de la semana 01 a la 28; para la SE-28, en el país el Covid-19 es el que más está circulando, seguido del Rinovirus y finalmente el virus de la Influenza A está en tercer lugar de circulación.

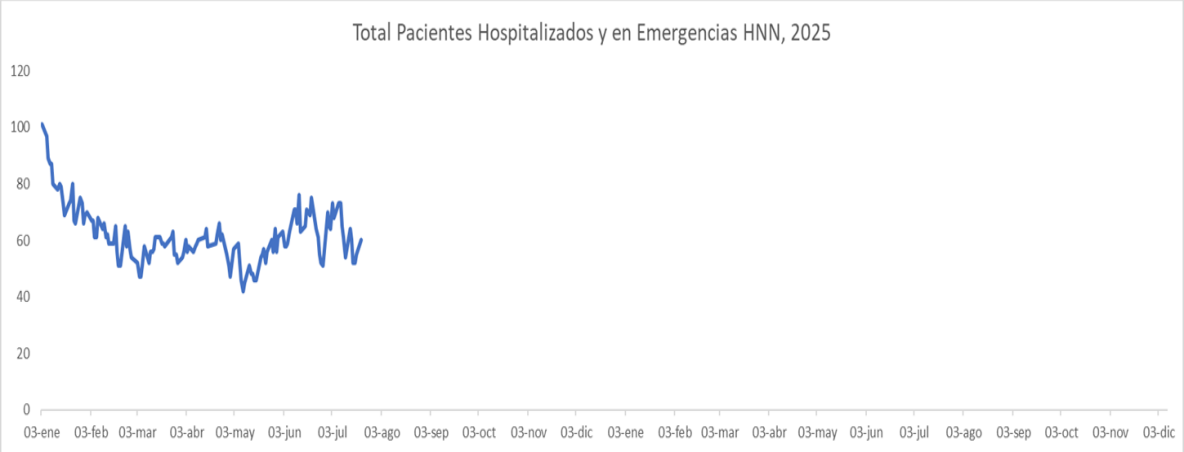
Gráfico 15.
Distribución de virus circulantes de la semana epidemiológica 01 a la 28 en Costa Rica, 2025.



Fuente: Matriz de Resultados de Laboratorio CCSS, Subárea de Vigilancia Epidemiológica 2025.

En relación con los datos específicos del Hospital Nacional de Niños, la situación que se ha presentado a la semana 29 del año 2025 es la siguiente:
Al 21 de julio del año en curso, correspondiente a la semana 29, el total de pacientes respiratorios hospitalizados son 60, lo que corresponde a un porcentaje de ocupación del 83.58%.

Gráfico 16.
Total de pacientes hospitalizados y en emergencias en la semana 28 del año 2025, Hospital Nacional de Niños.



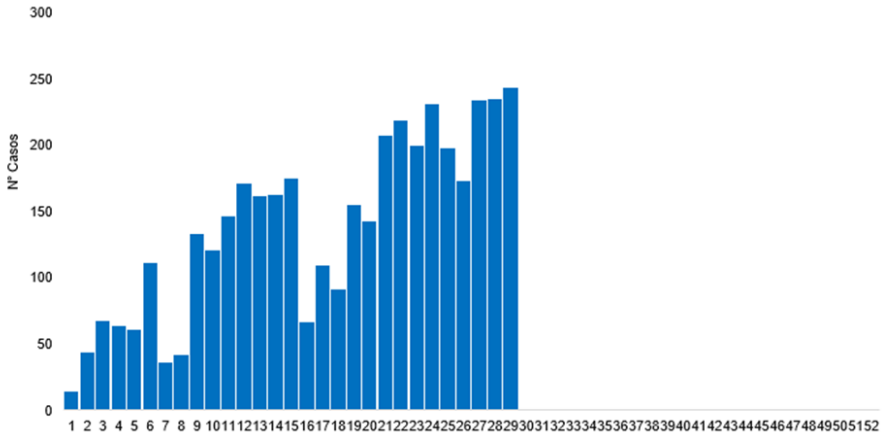
Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2025.

Como observaciones finales se puede indicar lo siguiente:

- IRAG con 8795 casos a la semana 27.
- IRAS con 849464 casos a la semana 27.
- ETI con 11966 casos reportados a la semana 27.
- Actualmente, la ocupación de camas respiratorias en el HNN es de un 83.58%
- En SE-28, el Covid-19 es el virus que más ha circulado, seguido del Rinovirus Covid-19 y en tercer lugar circula el Virus de Influenza A.

Para la enfermedad por COVID-19, durante la semana epidemiológica 29, se reportaron un total de 243 casos confirmados, lo que representa un aumento del 3.4% con respecto a la SE-28 del año 2025 que presentó 235 casos.

Gráfico 17.
Costa Rica: Casos COVID-19, según semana epidemiológica año 2025.

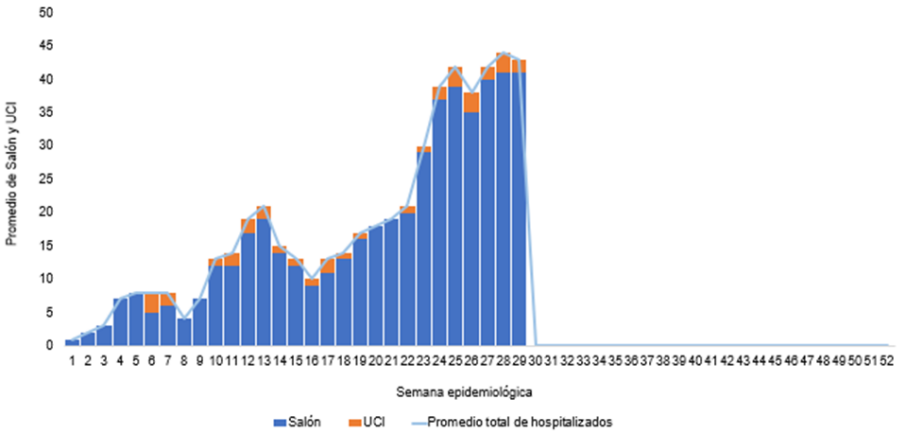


SE	Casos
1	14
2	44
3	67
4	64
5	61
6	111
7	36
8	42
9	133
10	121
11	146
12	171
13	162
14	163
15	175
16	66
17	109
18	31
19	155
20	143
21	207
22	219
23	200
24	231
25	198
26	173
27	234
28	235
29	243

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, C.C.S.S / Dirección de Vigilancia de Salud, Ministerio de Salud, 2025.

Con respecto a las hospitalizaciones en la semana epidemiológica 29, se reportó un promedio total de 42 hospitalizados, lo que representa un aumento del 10.5% con respecto a la SE-26 del año 2025 donde se registraron 38 hospitalizaciones.

Gráfico 18.
Costa Rica: Promedio total de hospitalizados en salón y Unidad de Cuidados Intensivos, según reporte semanal año 2025.

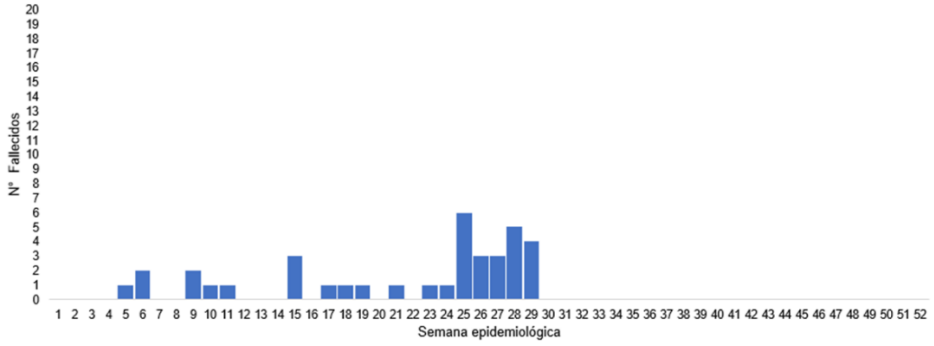


SE	Salón	UCI	Promedio total de hospitalizados
1	1	0	1
2	2	0	2
3	3	0	3
4	7	0	7
5	8	0	8
6	5	3	8
7	6	2	8
8	4	0	4
9	7	0	7
10	12	1	13
11	12	2	14
12	17	2	19
13	19	2	21
14	14	1	15
15	12	1	13
16	9	1	10
17	11	2	13
18	13	1	14
19	16	1	17
20	18	0	18
21	19	0	19
22	20	1	21
23	29	1	30
24	37	2	39
25	39	3	42
26	35	3	38
27	40	2	42
28	41	3	44
29	41	2	43

Fuente: Área de Estadística en Salud, CCSS/Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2025.

En relación con el comportamiento de las personas fallecidas asociadas a COVID-19, durante la semana epidemiológica 29, hubo 4 fallecidos; sin embargo, es importante indicar que estos son datos preliminares sujetos a la revisión de los casos.

Gráfico 19.
Costa Rica: Personas fallecidas asociadas a COVID-19, según reporte semanal año 2025.

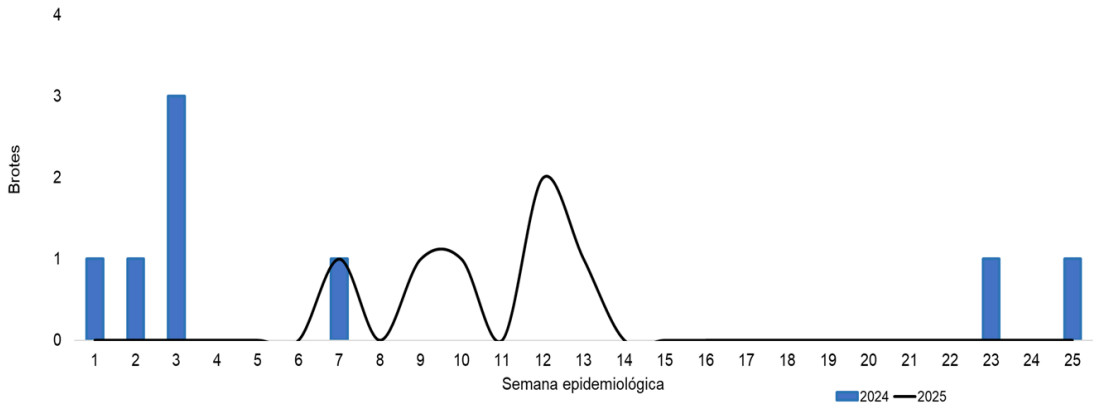


SE	Fallecidos
1	0
2	0
3	0
4	0
5	1
6	2
7	0
8	0
9	2
10	1
11	1
12	0
13	0
14	0
15	3
16	0
17	1
18	1
19	1
20	0
21	1
22	0
23	1
24	1
25	6
26	3
27	3
28	5
29	4

Fuente: Área de Estadística en Salud, C.C.S.S. / Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2025.

Para la semana epidemiológica 25 no se reportó ningún brote asociado a COVID-19.

Gráfico 20.
Brotes de covid-19, por semana epidemiológica en Costa Rica, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, 2025.

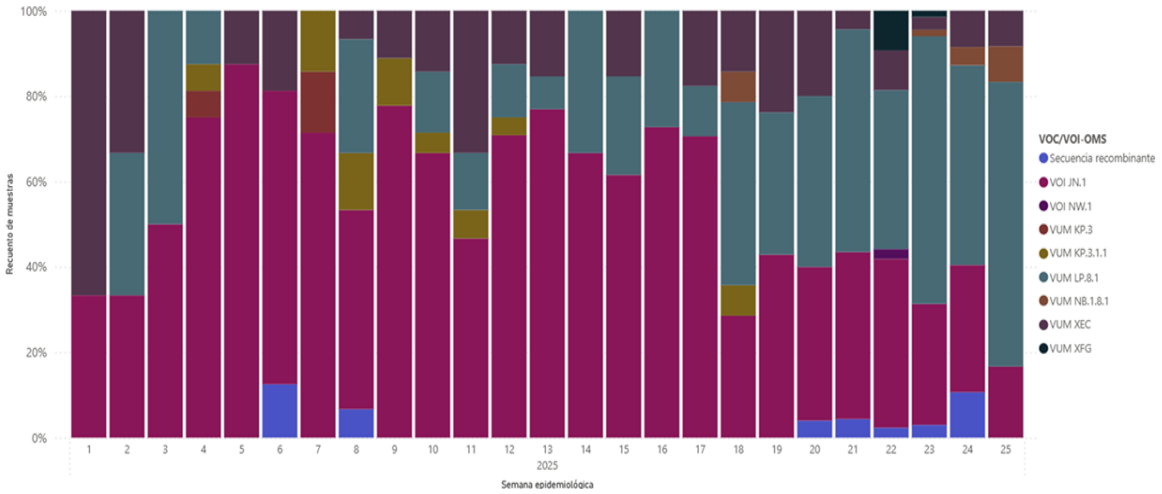
Nota: Se reportaron 24 brotes en el año 2024 y se han reportado 6 brotes en el año 2025

Variantes genómicas

Según el informe interactivo de INCIENSA revisado el 22 de julio del 2025, se reporta lo siguiente.

Gráfico 21.

Costa Rica: Proporción de linaje identificados, para Variante de Preocupación (VOC) Ómicron, Variante de Interés (VOI) y Variantes Bajo Monitoreo (VUM), por semana epidemiológica SE 1-25 del 2025.



Fuente: Sistema de Información de INCIENSA, CCSS, DATOS Facultad de Microbiología UCR, actualizado en informe interactivo en Vigilancia genómica SARS-CoV-2 al 24 de julio del 2025.

En relación con la proporción relativa de sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el periodo comprendido entre la SE-1 y la 25 del año 2025, se tiene la siguiente información.

Cuadro 1
Costa Rica: Proporción relativa de Sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el período de las semanas epidemiológicas 1-25 del 2025

Linaje Pangolin	Cantidad	%
Secuencia recombinante	13	2.80
VOI JN.1	225	48.39
VOI NW.1	1	0.22
VUM KP.3	2	0.43
VUM KP.3.1.1	10	2.15
VUM LP.8.1	152	32.69
VUM NB.1.8.1	5	1.08
VUM XEC	52	11.18
VUM XFG	5	1.08
Total	465	98.92

Fuente: INCIENSA, informes interactivos de variantes genómicas, corte 24 de julio 2025.

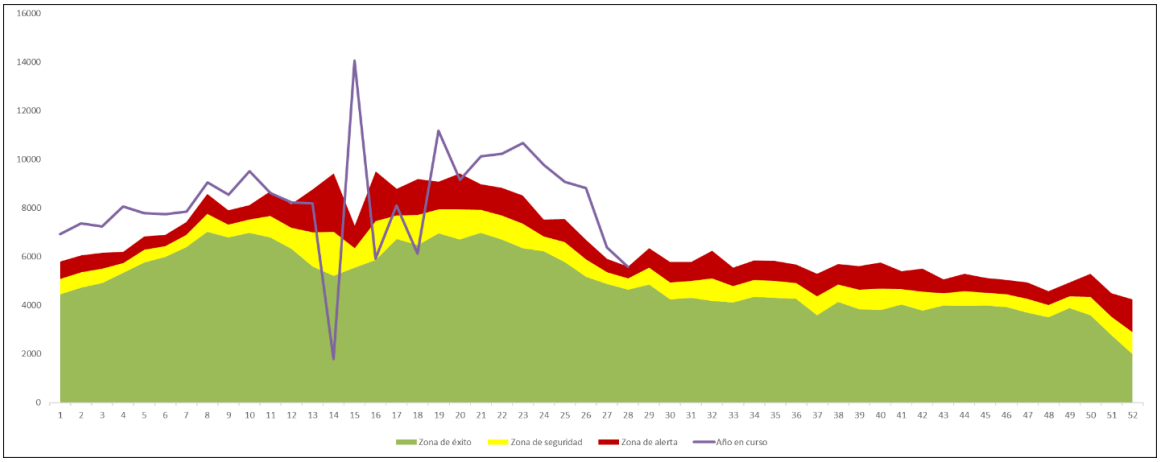
Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 21 de julio 2025.

Ivannia Caravaca Rodríguez.
Unidad de Epidemiología.
Dirección de Vigilancia de la Salud

En la semana epidemiológica 28 del 2025 se presentan 233353 casos acumulados de EDA. Según el comportamiento epidemiológico de este evento, se denota una curva epidémica en zona de alerta, con una tasa de 4357 casos de diarrea por cada 100 000 habitantes.

La incidencia de las EDA para la Semana Epidemiológica (SE) 28 refleja una disminución de casos notificados en relación con el 2023, año referente por el registro del aumento de casos y tasas por 100 000 habitantes en todo el territorio nacional. Para la SE 28 se continúa observando una predisposición disminuida en la frecuencia de casos, observándose una tendencia a la baja comparado con los años anteriores, es evidente que los fenómenos climáticos del niño y la niña afectan la cantidad de casos de diarrea, este año con el fenómeno de la niña se muestra a la fecha el canal endémico en zona de alerta situación semejante en el año 2023 donde se atravesó el mismo fenómeno. Se destaca que los datos son preliminares, y actualmente se encuentran los datos en revisión, por lo que puede presentarse afectación en el canal endémico.

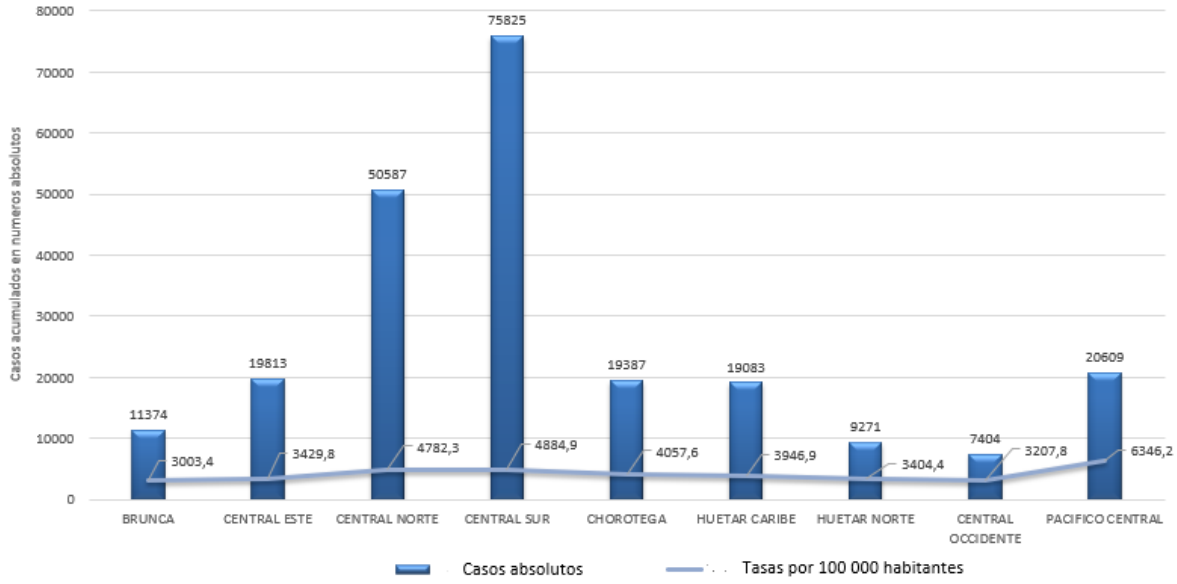
Gráfico 1
Costa Rica. Canal endémico para EDA por semana epidemiológica hasta la SE 28. Años 2017- 2025. (Se excluyen del 2020 al 2022 por pandemia COVID-19)



Fuente: Datos preliminares, Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Los 12 cantones con mayores tasas de incidencia de EDA a la SE 28 son: Santa Cruz, Orotina, Vázquez de Coronado, Montes de Oro, Puntarenas, Garabito, , Flores, San Rafael, Matina, Alajuela, Goicochea, Nandayure, donde predominan las tasas más altas. Las Regiones Rectoras con más casos son: Pacifico Central, Central Norte, Central Sur. El grupo de edad más afectado es el de adultos de 20 a 39 años.

Gráfico 2
Costa Rica. Incidencia de casos de EDA, según región del Ministerio de Salud. SE 28, 2025.



Fuente: Datos preliminares. Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Se recomienda retomar las campañas de educación a la población del Protocolo de Lavado de Manos, las adecuadas prácticas de higiene personal y de cocción y manipulación de alimentos.
El sistema de salud reporta una alta frecuencia de casos de diarreas, ya sean virales o bacterianas, superiores al comportamiento usual, el Protocolo de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos dirige el proceso de la investigación adecuada de los casos, así como los flujogramas de trabajo ante diferentes posibles causas, es importante retomar las actividades de vigilancia e investigación ante las alertas.

Meningitis

Franchina Murillo Picado
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Paola Pérez Espinoza
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

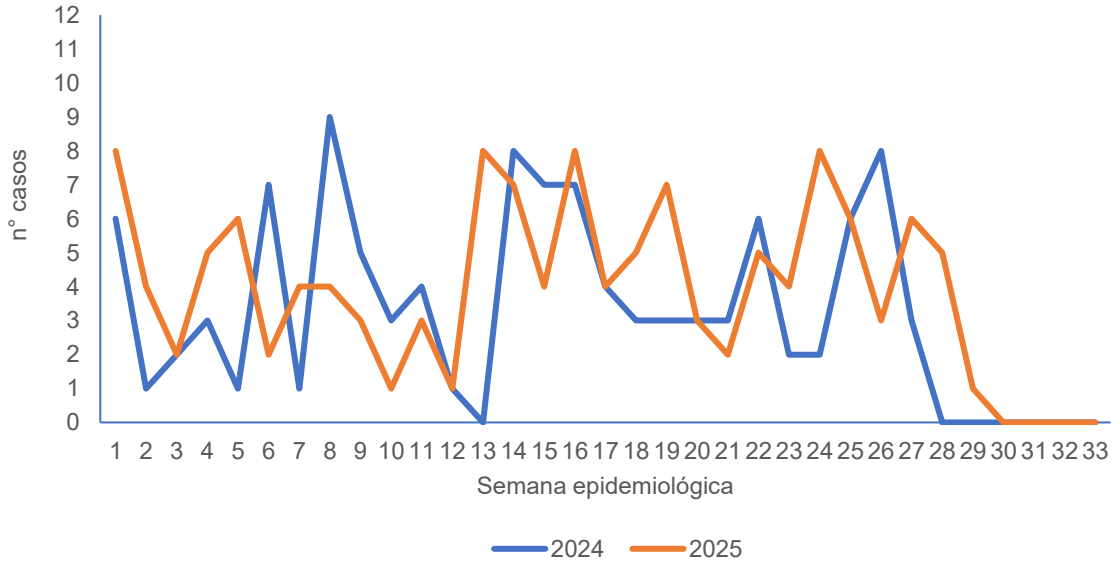
La meningitis es una peligrosa inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, causada principalmente por una infección bacteriana o vírica.

La meningitis causada por una infección bacteriana suele ser la más grave que provoca unas 250,000 muertes por año y posibles epidemias de rápida propagación. Ocasiona la muerte de una de cada diez personas infectadas, en su mayoría niños y jóvenes y deja a una de cada cinco con discapacidades duraderas, como convulsiones, pérdida de audición y visión, daños neurológicos y deterioro cognitivo.

En Costa Rica, hasta la semana epidemiológica 28 del año 2025, se han registrado 129 casos sospechosos de meningitis reportados mediante boleta VE01, lo que representa una tasa de incidencia de 2,4 por cada 100.000 habitantes. En comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 108 casos, se observa un incremento del 19,4%.

De las 9 Regiones del Ministerio de Salud, la Región Central Este y la Región Central Sur notificaron el 24,0% de los casos (31/129) respectivamente, seguido de la Central Norte con el 21,7% (28/129).

Figura 1.
Costa Rica: Casos sospechosos de meningitis comparativa año 2024 con el 2025 a la semana epidemiológica 28, 2025



Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

En la siguiente tabla se enlista los cantones con las tasas más altas de meningitis. Turrubares de la provincia de San José es el que tiene la tasa más alta de 13,1, seguido de Dota también de la provincia de San José con 12,2 y Cartago con 10,1.

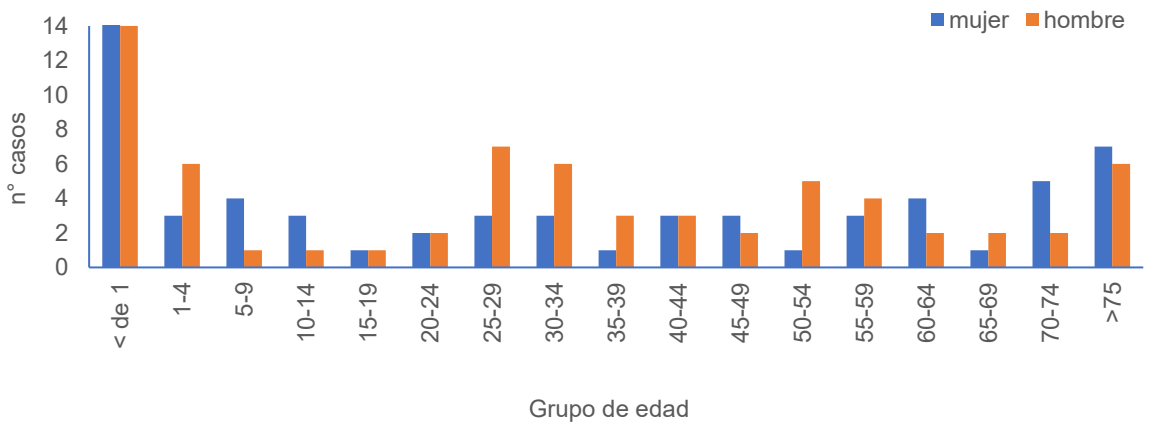
Figura 2.
Costa Rica: Casos notificados de meningitis según cantón, acumulado a la semana epidemiológica 28, 2025 (tasa p/100.000 habitantes)

cantón	casos	tasa
Turrubares	1	13,8
Dota	1	12,2
Cartago	17	10,1
Osa	3	9,5
Cañas	3	8,7
Santa Cruz	6	8,0
Sarapiqui	7	7,4
Leon Cortes	1	7,0
Alvarado	1	6,3
Jimenez	1	6,1
Liberia	5	6,0
Quepos	2	5,7
Tarrazu	1	5,2
Santa Barbara	2	4,4
Valverde Vega	1	4,3
Perez Zeledon	6	4,2
Talamanca	2	4,2
Turrialba	3	4,1
Bagaces	1	3,9
Flores	1	3,8
La Union	4	3,4
San Rafael	2	3,4
Moravia	2	3,1
Aserri	2	3,0
Alajuelita	3	3,0
Alajuela	10	3,0
Goicoechea	4	2,8
Esparza	1	2,5
Desamparados	6	2,4
Palmares	1	2,3
San Jose	8	2,2
El Guarco	1	2,1
Grecia	2	2,0
Naranjo	1	2,0
Barva	1	2,0
Santo Domingo	1	2,0
Limon	2	2,0
Nicoya	1	1,7
Guacimo	1	1,7
Santa Ana	1	1,6
Montes de Oca	1	1,6
Paraiso	1	1,5
Siquirres	1	1,5
Escazu	1	1,4
Heredia	2	1,3
Pococi	2	1,2
San Carlos	2	0,9
Total	**129**	**2,4**

Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

La figura 3, indica la distribución de los casos sospechosos según sexo y grupo de edad. El 48,0% de los casos (62/129) son mujeres y el 51,9% (67/129) son hombres. El 22,4% de los casos (29/129) son menores de 1 año.

Figura 3. Costa Rica: Casos sospechosos por meningitis según sexo y edad, a la semana epidemiológica 28, 2025



Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

Infecciones de transmisión sexual

Pamela Domínguez Saavedra
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Stephany Alvarado Garita
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

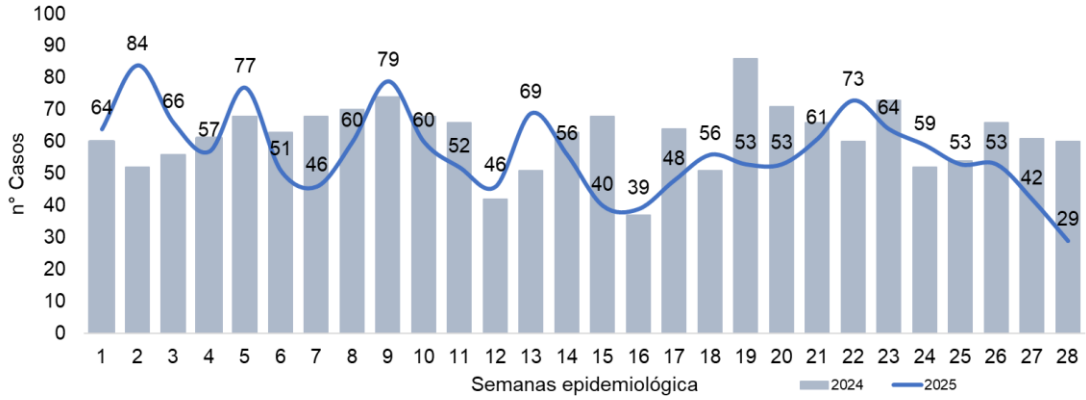
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), son de reporte obligatorio según el Reglamento de Vigilancia de la Salud 40556-S. Por consiguiente, la vigilancia es relevante para la salud pública del país. Para las primeras 28 semanas del año 2025, se han reportado las siguientes ITS: sífilis en todas sus formas, gonorrea, herpes virus y virus del papiloma humano.

Sífilis en todas sus formas

Es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria *Treponema pallidum*, la cual es totalmente prevenible y tratable. Esta infección se trasmite por relaciones sexuales sin el uso de condón y de la madre al bebé durante el embarazo. Por ende, esta infección afecta a la morbilidad y mortalidad del país.

Para las primeras 28 semanas del 2025, se han notificado 1590 casos con una tasa 29,7 por 100 000 habitantes, en el mismo periodo del año 2024 se reportaron 1731 casos, lo que representa para el año 2025 un descenso del 8,14% con 141 casos menos. En el gráfico 1, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 1.
Costa Rica: Casos confirmados por sífilis en todas sus formas, según fecha de inicio de síntomas en el reporte semanal, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares, sujetos a ser actualizados.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento epidemiológico de esta enfermedad en las primeras 28 semanas del año, se reportaron en los hombres un 58,5% de los casos (923/1590), con una tasa de 34,3 por 100 000 habitantes, las mujeres presentan el 41,95% de los casos (667/1590), con una tasa de 25,1 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporto son: 20 a 64 años con 80,75% (1284/1590), seguidos por el de mayores de 65 años con 9,6% con (153/1590), luego por el grupo de 15 a 19 años con 4,7% con (74/1590), y los menores de 1 año con el 4,8% de los casos (76/1590), los menores de 10 a 14 años un caso, grupo de 1 a 4 años dos casos y el grupo de 5 a 9 años sin caso, ver cuadro 1.

Cuadro 1.
Costa Rica: Casos de sífilis en todas sus formas, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 28 del 2025.

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	76	112,5
de 1 a 4 años	2	0,7
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	1	0,3
de 15 a 19 años	74	19,5
de 20 a 24 años	199	51,2
de 25 a 29 años	246	57,9
de 30 a 34 años	238	53,6
de 35 a 39 años	175	38,7
de 40 a 44 años	136	33,3
de 45 a 49 años	107	30,8
de 50 a 54 años	65	22,1
de 55 a 59 años	56	20,1
de 60 a 64 años	62	23,7
de 65 a 69 años	49	22,9
de 70 a 74 años	40	25,7
75 años y más	64	30,3
Total	1590	29,70

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el siguiente cuadro, se presenta el comportamiento de esta enfermedad, según provincias.

Cuadro 2.
Costa Rica: Casos notificados de sífilis en todas sus formas según provincias de procedencia. Números absolutos. (Tasa p/100.000 habitantes), en semana 28 del 2025.

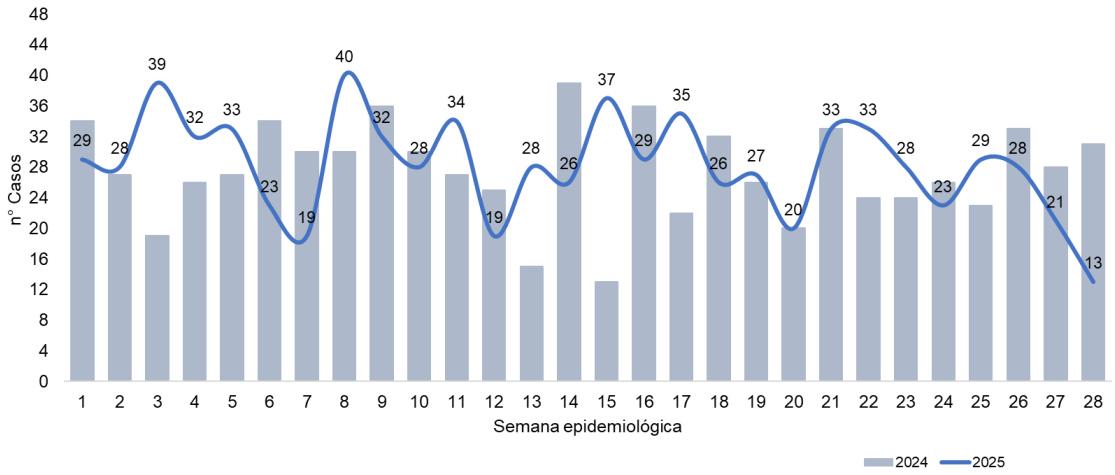
Provincias	Nº	Tasa
San José	546	31,8
Alajuela	255	23,3
Cartago	211	37,9
Heredia	119	21,3
Guanacaste	79	18,8
Puntarenas	122	23,1
Limón	258	53,4
Total	1590	29,70

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Gonorrea

Es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*, la cual es prevenible y tratable. Esta enfermedad se trasmite por relaciones sexuales sin protección y de la madre al bebé durante el parto. Por consiguiente, esta infección afecta a la salud pública del país, en las primeras 28 semanas del 2025, se han notificado 792 casos con una tasa de 14,8 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 770 casos, lo que representa para el año 2025 un ascenso del 2,85 % con 22 casos más. En el gráfico 2, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años años 2024 y 2025.



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento de esta enfermedad en las primeras 28 semanas del 2025, se reporta en los hombres un 84,22% de los casos (667/792), con una tasa de 24,8 por 100 000 habitantes. En las mujeres se ha reportado el 15,78% de los casos (125/792), con una tasa de 4,7 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporte son: 20 a 64 años con 82,95% (657/792), seguidos por el grupo de 15 a 19 año con 14,0% (111/792), y los mayores de 65 años con 2,0% (16/792), los menores de 1 año dos casos y los de 1 a 14 años con seis casos, ver cuadro 3.

Cuadro 3
Costa Rica: Casos de gonorrea por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 28 del 2025.

Grupos de edad	Casos	Tasa
Menos 1 año	2	3,0
1 a 4	2	0,7
5 a 9	1	0,3
10 a 14	3	0,8
15 a 19	111	29,2
20 a 24	196	50,4
25 a 29	154	36,2
30 a 34	116	26,1
35 a 39	78	17,2
40 a 44	43	10,5
45 a 49	18	5,2
50 a 54	24	8,2
55 a 59	19	6,8
60 a 64	9	3,4
65 a 69	10	4,7
70 a 74	3	1,9
Más 75 años	3	1,4
Total	792	14,80

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 4, se presentan el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 4
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según provincia. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 28 del 2025.

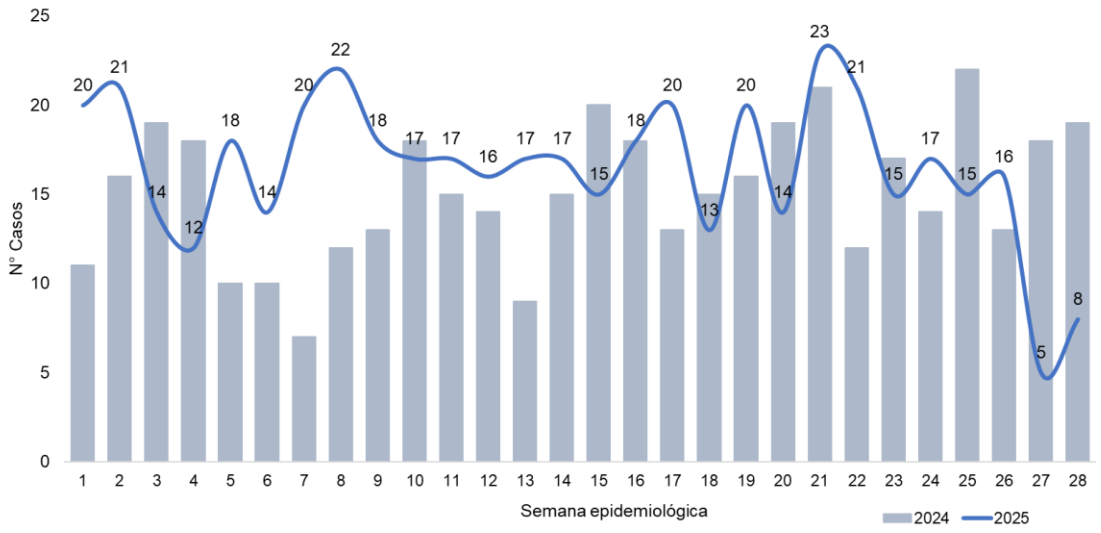
Provincias	Casos	Tasa
San José	285	16,6
Alajuela	122	11,2
Cartago	68	12,2
Heredia	67	12,0
Guanacaste	44	10,5
Puntarenas	91	17,3
Limón	115	23,8
Total	792	14,80

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus Herpes

El virus del herpes es otra de las Infección de transmisión sexual, que se ha reportado en las primeras 27 semanas del año en curso, con 463 casos con una tasa de 8,6 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 424 casos, lo que representa para el año 2025 un incremento del 9,0%, con 39 casos más que el periodo anterior. En el gráfico 3, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 3.
Costa Rica: Casos notificados por el virus del herpes, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025.



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento del virus del herpes en las primeras 28 semanas del año se ha notificado en mujeres un 67,17% de los casos (311/463), con una tasa de 11,7 por 100 000 habitantes, en hombres se reportó el 32,83% de los casos con (152/463), con una tasa de 5,6 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad y los que reportan más son: 20 a 64 años con 81,64% (378/463), seguidos por 15 a 19 años con 13,17% (61/463), mayores de 65 años con 4,10% con (19/463), los menores de 1 año reportan un caso y el de 10 a 14 años con cuatro casos, los otros grupos no reportan casos, ver cuadro 5.

Cuadro 5.
Costa Rica: Casos de virus del herpes, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 28 del 2025.

Grupos de edad	Caso	Tasa
Menos 1 año	1	1,5
1 a 4	0	0,0
5 a 9	0	0,0
10 a 14	4	1,1
15 a 19	61	16,1
20 a 24	86	22,1
25 a 29	68	16,0
30 a 34	64	14,4
35 a 39	56	12,4
40 a 44	33	8,1
45 a 49	29	8,4
50 a 54	10	3,4
55 a 59	16	5,7
60 a 64	16	6,1
65 a 69	11	5,1
70 a 74	6	3,9
Más 75 años	2	0,9
Total	463	8,60

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 6, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 6
Costa Rica: Casos notificados por virus del herpes, según provincias. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 28 del 2025.

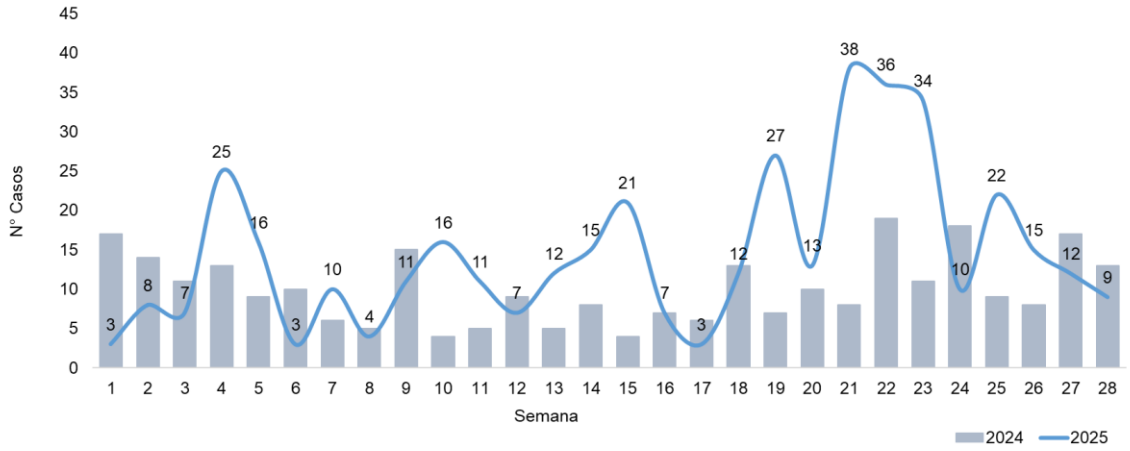
Provincias	Casos	Tasa
San José	223	13,0
Alajuela	50	4,6
Cartago	32	5,8
Heredia	32	5,7
Guanacaste	10	2,4
Puntarenas	58	11,0
Limón	58	12,0
Total	463	8,60

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus del Papiloma Humano (VPH)

Es una de Infección que se trasmite por contacto de la piel o por relaciones sexuales sin protección, se puede prevenir con el uso de condones y no tener relaciones sexuales cuando la pareja tiene síntomas. En las primeras 28 semanas del 2025, se notificaron 407 casos con una tasa de 7,6 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 281 casos, lo que representa para el año 2025 un incremento del 44,87%, con 126 casos más que el periodo anterior ver gráfico 4.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados por virus del papiloma humano, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento del VPH en las primeras 28 semanas del año, según sexo se notificaron en las mujeres un 90,91% (370/407), con una tasa de 13,90 por 100 000 habitantes, en los hombres se reportó el 9,09% (37/407), con una tasa de 1,4 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporte son: 20 a 64 años con 96,6% (393/407), seguidos por 15 a 19 años con 2,9% (12/407), los mayores 65 años dos casos y los otros grupos no reportan casos, ver cuadro 7.

Cuadro 7.
Costa Rica: Casos notificados por virus del papiloma humanos, por grupos de edad. Número absoluto. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 28 del 2025.

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	0	0,0
de 1 a 4 años	0	0,0
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	0	0,0
de 15 a 19 años	12	3,2
de 20 a 24 años	27	6,9
de 25 a 29 años	24	5,6
de 30 a 34 años	72	16,2
de 35 a 39 años	86	19,0
de 40 a 44 años	49	12,0
de 45 a 49 años	45	13,0
de 50 a 54 años	25	8,5
de 55 a 59 años	41	14,7
de 60 a 64 años	24	9,2
de 65 a 69 años	2	0,9
de 70 a 74 años	0	0,0
75 años y más	0	0,0
Total	407	7,60

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Cuadro 8.
Costa Rica: Casos notificados por virus del papiloma humano, según provincia. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 28 del 2025.

Provincias	Nº	Tasa
San José	96	5,6
Alajuela	30	2,7
Cartago	15	2,7
Heredia	7	1,3
Guanacaste	101	24,0
Puntarenas	154	29,2
Limón	4	0,8
Total	407	7,60

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Miasis por gusano barrenador en humanos

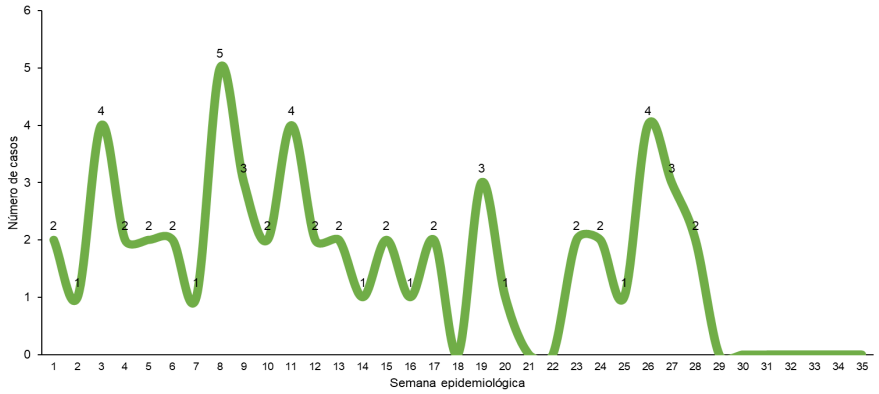
María José Lafuente González
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos de miasis por gusano barrenador en humanos para la semana epidemiológica (SE) 29 del año 2025, según establece el Reglamento de Vigilancia de la Salud Decreto N°40556-S y el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos es un evento de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.
En relación con la notificación de esta miasis, por medio de la boleta VE-01, para el año 2025 a la SE 29, se tienen los siguientes datos:

- Casos acumulados de miasis por gusano barrenado en humanos suman un total de 56 casos
- Casos por grupos de edad quinquenal tienen un predominio en las personas de 20 a 64 años (27/56) y las adultas de 65 y más años con más casos reportados (26/56)

Gráfico 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador según SE de la 01 a la 29, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

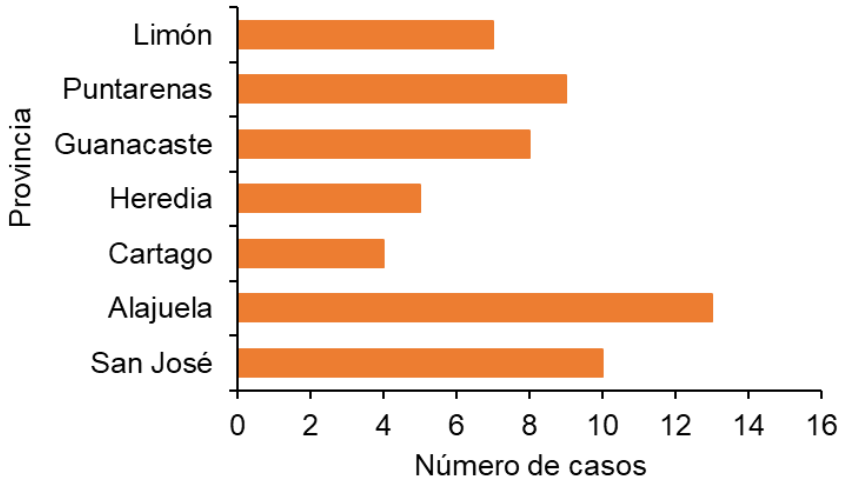
Cuadro 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasa (tasa p/100.000 habitantes) según grupo de edad, de la SE 01 a la 29, 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
TOTAL	**56**	**1,0**
< 1	0	0,0
1 a 4	0	0,0
5 a 9	0	0,0
10 a 14	2	0,5
15 a 19	1	0,3
20 a 24	3	0,8
25 a 29	3	0,7
30 a 34	1	0,2
35 a 39	1	0,2
40 a 44	3	0,7
45 a 49	5	1,4
50 a 54	1	0,3
55 a 59	3	1,1
60 a 64	7	2,7
65 a 69	5	2,3
70 a 74	4	2,6
≥75	17	8,1

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

El comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos, en el año 2025, presenta un predominio en los hombres con 36 casos notificados con una tasa de 1,3 por 100.000 habitantes y en las mujeres con 20 casos notificados con una tasa de 0,8 por 100.000 habitantes.

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos según provincia de procedencia, de la SE 01 a 29, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el gráfico 2, se presenta el comportamiento de esta enfermedad por número de casos notificados a la SE 29 según provincia de procedencia, presentando mayor número de casos la provincia de Alajuela (13/56) seguido por la provincia de San José (10/56).

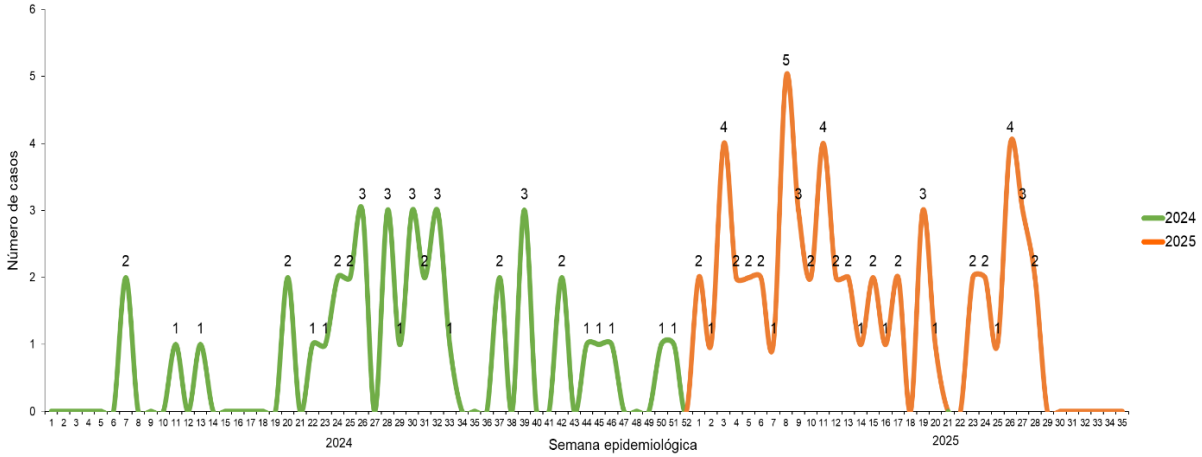
Cuadro 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasa (tasa p/100.000 habitantes) según región del Ministerio de Salud de procedencia, de la SE 01 a la 29, 2025

Regiones	Casos	Tasa
Total	**56**	**1,0**
Central Norte	9	0,9
Central Sur	9	0,6
Chorotega	8	1,7
Huetar Caribe	7	1,4
Central Occidente	6	2,6
Brunca	6	1,6
Pacifico Central	5	1,5
Central Este	4	0,7
Huetar Norte	2	0,7

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 202

En el cuadro 2, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las nueve regiones del Ministerio de Salud, siendo la región Central Norte (9/56) y Centra Sur (9/56) las que presentan el mayor número de casos notificados.

Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, según SE, de la SE 01 a la 52 del 2024 al corte de la SE 29 del 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024 y 2025

En el gráfico 3 se puede observar el comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos por SE 01 a 52 del 2024 y SE 01 a 29 del 2025 y en el cuadro 3 el comportamiento de los casos de la SE 01 a 29 del 2024 y 2025, observando un aumento significativo de los casos durante la SE 08 del 2025, con un total de 56 casos confirmados por esta enfermedad, siendo que para la SE 29 del 2024 se confirmaron 19 casos de miasis por gusano barrenador en el país.

Cuadro 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador a la SE 29 del 2024 y 2025

SE	Número de casos	
	2024	2025
Total	**19**	**56**
1	0	0
2	0	1
3	0	5
4	0	2
5	0	1
6	0	3
7	2	2
8	0	3
9	0	4
10	0	2
11	1	3
12	0	2
13	1	4
14	0	1
15	0	2
16	0	0
17	0	2
18	0	1
19	0	2
20	2	0
21	0	2
22	1	0
23	1	1
24	2	3
25	2	1
26	3	2
27	0	3
28	3	2
29	1	2

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024 y 2025

Dado que la mosca continúa circulando en el territorio nacional y existe la declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación de la enfermedad de Gusano Barrenador, Decreto Ejecutivo N° 44382–MAG (*Cochliomyia hominivorax*), es de suma importancia que ante la identificación de un caso sospechoso en humanos se realice el abordaje bajo el enfoque de **Una Sola Salud**, mediante coordinación interinstitucional Ministerio de Salud-Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)-Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) según corresponda, para identificar casos sospechosos en humanos y/o animales y puedan ser atendidos de manera oportuna.

A continuación, se brinda algunas generalidades de prevención y control de esta enfermedad:

- Mantener higiene personal, lavarse las manos regularmente con agua y jabón
- Control, tratamiento e higiene en lesiones en piel de acuerdo con la recomendación del médico tratante
- Asistir al establecimiento de salud público o privado cuando presente síntomas asociados a la enfermedad, tales como: dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia, se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la lesión
- Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, realizando revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas e informar a las autoridades de salud animal (SENASA-MINAE) sobre la aparición de animales con gusaneras para que reciban atención oportuna